ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА · ЛЕКЦИЯ 1 · ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Медучреждения, сестринский процесс и потребности пациента

Виды медицинских учреждений, амбулаторная и стационарная помощь, цели сестринского процесса, 14 основных потребностей человека

👤 Сажнова Елена Юрьевна

1. Виды медицинских учреждений
2. Амбулаторная и стационарная помощь
3. Цели сестринского процесса
4. Основные потребности человека
5. Безопасная больничная среда
6. Сестринский процесс подробно · подробнее
7. Лечебно-охранительный режим · подробнее

Суть — главное одной фразой | Простыми словами | Важно | Таблицы

1 Виды медицинских учреждений

СУТЬ
Медпомощь оказывают в учреждениях разного уровня: от роддома и поликлиники до крупных федеральных центров.

Лекция открывает курс **«Сестринское дело в стоматологии»**. Первый вопрос — какие виды медицинских учреждений мы знаем.



Уровни медицинских учреждений

1. **Роддома**.
2. **Поликлиники** — детские и взрослые.
3. **Стационары и медцентры**: городские, федеральные, **ЦРБ** (центральная районная больница), **ФАП** (фельдшерско-акушерский пункт).
4. **Многопрофильные и специализированные** учреждения.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
ФАП — маленький пункт в посёлке, где работают фельдшер и акушерка. ЦРБ — главная больница района. Федеральный центр — самый высокий уровень, туда направляют сложных пациентов.

2 Амбулаторная и стационарная помощь

СУТЬ
Амбулаторно лечат без госпитализации, в стационаре пациент лежит и за ним наблюдают круглосуточно.

Вид помощи	Где и как
Амбулаторно-поликлиническая (без госпитализации)	Поликлиники (взрослые и детские): первичный приём. Узкие специалисты (кардиолог, хирург и т. д.): консультация и диагностика. Диспансеры (онко-, кожно-венерологический, туберкулёзный, психиатрический): наблюдение хронических больных.
Стационарная (24/7)	Круглосуточно; бывает многопрофильной.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Пришёл к врачу и ушёл домой — амбулаторно. Лёг в палату — стационар.

3 Цели сестринского процесса

СУТЬ
Медсестра обеспечивает пациенту комфорт и помогает удовлетворять базовые потребности, которые он сейчас не может удовлетворить сам.

1. Обеспечить **максимально возможный физический и психологический комфорт** пациента.
2. Помочь пациенту в обеспечении **основных физиологических потребностей**.



Сестринский процесс — 5 этапов по кругу

ⓘ Этапы сестринского процесса: обследование → сестринский диагноз (проблемы пациента) → планирование → реализация → оценка результата.

4 Основные потребности человека

СУТЬ
Потребности — физиологические и психологические факторы, без которых человек не может сохранить здоровье и выжить.

Основные потребности человека — физиологические и психологические факторы, необходимые человеку для поддержания здоровья и выживания.



14 основных потребностей человека (по лекции)

1. Нормально дышать.
2. Употреблять достаточное количество пищи.
3. Употреблять достаточное количество жидкости.
4. Выделять продукты жизнедеятельности.

5. Спать и отдыхать.
6. Двигаться.
7. Самому одеваться и раздеваться.
8. Поддерживать нормальную температуру тела.
9. Быть чистым — поддерживать личную гигиену.
10. Быть здоровым — вести здоровый образ жизни.
11. Общаться.
12. Иметь жизненные ценности.
13. Избегать опасности.
14. Работать, учиться; для детей — играть.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Медсестра смотрит, какие пункты пациент сейчас не может выполнить сам (например, не может встать и одеться), и закрывает именно их.

5 Безопасная больничная среда

СУТЬ
Безопасная среда в больнице держится на трёх опорах: инфекционная безопасность, личная гигиена и лечебно-охранительный режим.



Из чего складывается безопасная больничная среда



Слайд с занятия: безопасная больничная среда

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Лечебно-охранительный режим — это покой, тишина, распорядок дня, правильный двигательный режим и профилактика падений.

📖 **Подробнее — дополнительные материалы к теме**

6 Сестринский процесс подробно

СУТЬ

Сестринский процесс — научный метод организации ухода: медсестра последовательно выявляет проблемы пациента и решает их.



Пять этапов сестринского процесса

Этап	Что делает медсестра
1. Обследование	собирает субъективные (жалобы, расспрос) и объективные данные (осмотр, измерения: температура, пульс, АД, ЧДД, рост, вес)
2. Сестринский диагноз	определяет проблемы пациента — какие потребности нарушены (настоящие и потенциальные, приоритетные)
3. Планирование	ставит цели (краткосрочные и долгосрочные) и составляет план сестринских вмешательств
4. Реализация	выполняет план: независимые, зависимые (по назначению врача) и взаимозависимые вмешательства
5. Оценка	проверяет, достигнута ли цель; при необходимости корректирует план

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Это как цикл: узнал → понял проблему → спланировал → сделал → проверил. Если не сработало — снова по кругу.

7 Лечебно-охранительный режим

Лечебно-охранительный режим (ЛОР) — комплекс профилактических и лечебных мероприятий, обеспечивающих пациенту максимальный физический и психический покой. **Цель** — создать комфортные и безопасные условия, способствующие скорейшему выздоровлению. Элементы: режим эмоциональной безопасности, правила внутреннего распорядка, режим рациональной двигательной активности, безопасная больничная среда.



Безопасная больничная среда



Слайд с занятия: структура безопасной больничной среды

Режимы двигательной активности

Режим двигательной активности	Что можно
Строгий постельный	нельзя садиться и поворачиваться без помощи; весь уход в постели
Постельный	можно поворачиваться в постели, сидеть на краю кровати (по разрешению)
Полупостельный (палатный)	ходить в пределах палаты, туалет, приём пищи в палате
Общий	свободно ходить по отделению, иногда — по территории

Факторы риска падения

- возраст старше 65 лет, падения в анамнезе;
- головокружение, слабость, нарушения походки и равновесия, ортостатическая гипотензия;
- нарушение зрения и слуха, спутанность сознания, деменция;
- приём седативных, снотворных, гипотензивных, мочегонных препаратов;
- частое мочеиспускание, недержание; послеоперационный период; в/в инфузии;
- внешние: скользкий пол, плохое освещение, неудобная обувь, отсутствие поручней, высокая кровать.

Профилактика падений и травм

- кровать в низком положении на тормозах, при необходимости — бортики;
- кнопка вызова, очки, вода, судно — в зоне досягаемости;
- ночное освещение, сухой нескользящий пол, поручни в коридоре и санузле;
- удобная нескользящая обувь, ходунки, трость, кресло-каталка;
- помощь при вставании и перемещении, медленный подъём с кровати;
- маркировка пациентов высокого риска (браслет, табличка), регулярные обходы, обучение пациента и родственников.

ⓘ Риск падения оценивают по шкале Морсе при поступлении: 0–24 — нет риска, 25–50 — низкий, 51 и более — высокий.

Нормы этического общения

- с пациентом — на «вы», по имени-отчеству, вежливо и терпеливо; врачебная тайна; диагноз и прогноз сообщает врач;
- в коллективе — уважение, субординация, взаимопомощь; не критиковать коллег при пациентах.

📌 Что запомнить

- Виды учреждений: роддом, поликлиника, стационар/медцентр (городской, федеральный, ЦРБ, ФАП), многопрофильные и специализированные.
- ФАП — фельдшерско-акушерский пункт; ЦРБ — центральная районная больница.
- Амбулаторно — без госпитализации; стационар — 24/7.
- Цели сестринского процесса: максимальный физический и психологический комфорт + помощь в основных физиологических потребностях.
- Потребности — факторы, необходимые для здоровья и выживания: дышать, есть, пить, выделять, спать, двигаться, одеваться, температура, гигиена, ЗОЖ, общаться, ценности, безопасность, работа/учёба/игра.

ИНТЕРЕСНО

Список из 14 потребностей восходит к модели американской медсестры Вирджинии Хендерсон, одной из основ сестринского процесса.

🃏 Вопросы для самопроверки

Что такое ФАП?
Фельдшерско-акушерский пункт

Что такое ЦРБ?
Центральная районная больница

Амбулаторная помощь — это…
Помощь без госпитализации (поликлиники, узкие специалисты, диспансеры)

Какие диспансеры названы на лекции?
Онкологический, кожно-венерологический, туберкулёзный, психиатрический

Две цели сестринского процесса
1) максимальный физический и психологический комфорт; 2) помощь в основных физиологических потребностях

Что такое основные потребности человека?
Физиологические и психологические факторы, необходимые для поддержания здоровья и выживания

«Быть чистым» означает…
Поддерживать личную гигиену

Особая потребность детей
Играть

✅ Тест с ответами

1. Что такое ФАП?
Ответ: Фельдшерско-акушерский пункт — ФАП — фельдшерско-акушерский пункт, обычно в сельской местности.

2. Помощь без госпитализации называется…
Ответ: амбулаторно-поликлинической — Амбулаторно-поликлиническая — пациент приходит и уходит домой.

3. Где ведут наблюдение хронических больных (онко, туберкулёз и т. п.)?
Ответ: В диспансерах — Диспансеры: онко-, кожвен, туб, психиатрический.

4. Какая из целей относится к сестринскому процессу?
Ответ: Обеспечить максимально возможный комфорт пациента — Медсестра обеспечивает физический и психологический комфорт и помогает в базовых потребностях.

5. «Быть здоровым» как потребность означает…

Ответ: вести здоровый образ жизни — В лекции: быть здоровым — вести здоровый образ жизни.

Конспект составлен по лекции и дополнительным материалам преподавателя. Иллюстрации: схемы — собственные; иконки Healthicons (MIT); рисунки Servier Medical Art (CC BY 3.0), DBCLS (CC BY 4.0) и OpenClipart (CC0) из коллекции Bioicons; слайды — материалы к занятиям.